TEMA 16 · Prevención y promoción de la salud. Detección precoz y factores de riesgo por etapas de la vida

Resumen OPE Enfermería SMS · Niveles de prevención, Carta de Ottawa, marco normativo, cribado y escalas, diagnósticos de riesgo, factores de riesgo y cuidados en infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, programas del SNS y del SMS

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
EpS	Educación para la Salud	Herramienta de la promoción y la prevención
SNS / SMS	Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud	
Ley 14/1986 (LGS) / Ley 16/2003 / Ley 33/2011	Ley General de Sanidad / Ley de Cohesión y Calidad del SNS / Ley General de Salud Pública	Marco de la prevención y la promoción
Ley 4/1994 / Ley 5/2001	Ley de Salud de la Región de Murcia / Ley de personal estatutario del SMS	
NAOS	Estrategia para la Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad (2005)	Obesidad, sobre todo infantil
PAPPS / semFYC	Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud / Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria	Qué cribados y consejos hacer por edades
TA / HTA / IMC	Tensión Arterial / Hipertensión Arterial / Índice de Masa Corporal	
IAM / EPOC	Infarto Agudo de Miocardio / Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	
UPP / MEC / MNA	Úlceras Por Presión / Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo / *Mini Nutritional Assessment*	Escalas de cribado
AUDIT / M-CHAT	*Alcohol Use Disorders Identification Test* / *Modified Checklist for Autism in Toddlers*	Alcohol / autismo
NANDA-I / NOC / NIC	Diagnósticos / Resultados / Intervenciones de enfermería	
SCORE / REGICOR	*Systematic Coronary Risk Evaluation* / Registre Gironí del Cor	Tablas de riesgo cardiovascular
VPH	Virus del Papiloma Humano	Cribado de cérvix
STOPP / START	*Screening Tool of Older Person's Prescriptions* / *Screening Tool to Alert to Right Treatment*	Medicamentos inapropiados / tratamientos que faltan
SPPB	*Short Physical Performance Battery*	Detecta fragilidad
EWGSOP2 / SARC-F	Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia en Personas Mayores / cuestionario de cribado de sarcopenia	
SRI	Sistema de Retención Infantil	Sillas del coche por peso o talla

1. Prevención y promoción: conceptos

Nivel (Leavell y Clark)	Periodo	Objetivo	Ejemplos
Primaria	Prepatogénico	**Reducir la incidencia**	Vacunas, EpS, cloración del agua, preservativo
Secundaria	Patogénico **subclínico**	**Detección precoz** (diagnóstico precoz), reducir la **prevalencia**	**Cribados**: mamografía, citología, prueba del talón (p. ej., **hipotiroidismo congénito**), toma de TA en sanos

Nivel (Leavell y Clark)	Periodo	Objetivo	Ejemplos
Terciaria	Enfermedad establecida	Reducir **complicaciones y secuelas**	Rehabilitación tras ictus o IAM, prevención del **pie diabético**, inhaladores en EPOC
Cuaternaria (Marc Jamoulle)	—	Medidas para **evitar, disminuir o paliar el daño de la propia actividad sanitaria** (iatrogenia, sobremedicalización)	No dar antibióticos en virasis, desprescribir

- **Promoción de la salud** (**Carta de Ottawa, 1986**): "proceso que permite a las personas **incrementar el control sobre su salud** para mejorarla". Enfoque positivo y **salutogénico**; la salud como **recurso para la vida cotidiana**. Antecedente: **Alma-Ata (1978)**, "Salud para todos en el año 2000".
- **Conferencias mundiales de promoción de la salud (OMS)**: **1.ª Ottawa (1986)**, la carta fundacional; **Nairobi (2009)**; **8.ª Helsinki (2013)**: **"Salud en todas las políticas"** (tener en cuenta en cualquier política pública su efecto en la salud); **Shanghái (2016)**: ODS; **Ginebra (2021)**: compromisos mundiales para lograr salud y equidad **sin destruir la salud del planeta** (sociedades del bienestar).
- Desintoxicación y deshabituación de drogas **no** son prevención primaria (son tratamiento); la primaria es la **educación sanitaria** (SMS 2023 y 2022).
- **Modelo PRECEDE (Green)**: factores **predisponentes** (conocimientos, creencias, **percepción del riesgo**), **facilitadores** (recursos, habilidades, accesibilidad) y **reforzantes** (apoyo, recompensas del entorno).
- **5 áreas de acción de Ottawa**: **políticas públicas saludables**, **entornos favorables**, **acción comunitaria**, **aptitudes personales** (EpS) y **reorientación de los servicios sanitarios**.

	Prevención	Promoción
Enfoque	Defensivo: evitar la enfermedad (modelo biomédico)	Positivo: ganar salud (salutogénico)
Diana	Grupos de riesgo o enfermos	**Toda la población**
Eje	**Factores de riesgo**	**Determinantes sociales**
Éxito	Menos morbimortalidad	Más calidad de vida y equidad

- Son **complementarias**: en la misma consulta se mide la TA (prevención) y se da consejo de ejercicio (promoción).

2. Marco normativo y estratégico

- **Ley 14/1986, General de Sanidad**: el sistema se orienta prioritariamente a la promoción y la prevención. **Ley 16/2003**: prevención y promoción en la cartera de servicios. **Ley 33/2011, General de Salud Pública**: la ley específica de salud pública.
- **Estrategia NAOS (2005)**: Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad, sobre todo en la **infancia** y la juventud. Lema **"Come sano y muévete"**; **no es competencia exclusiva del Ministerio** (implica a comunidades autónomas, ayuntamientos, escuelas, empresas); aborda los **menús escolares** y la oferta de las **máquinas expendedoras** de los colegios. Programas municipales y escolares **THAO** y **NEREU** (obesidad infantil).
- **Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS (2013)**: enfermedades crónicas; áreas: **alimentación, actividad física, bienestar emocional, tabaco y alcohol**. En su primera etapa priorizó a los **menores de 15 años y los mayores de 50**.
- **Estrategia de Salud Pública 2022**: marco de coordinación que **refuerza acciones y proyectos ya en marcha** (no define todas las acciones concretas).
- **Programa Activa (Murcia)**: programa comunitario de la Consejería de Sanidad para **prescribir ejercicio físico desde AP**, con la colaboración de los **ayuntamientos**; incluye también a personas con **problemas de salud mental** (no las excluye).
- Región de Murcia: **Ley 4/1994** de Salud; Ley 5/2001 de personal estatutario del SMS. **4 programas del SMS**: **salud infantil**, **salud escolar**, **atención al adulto** y **atención a las personas mayores** (este incluye el **apoyo al cuidador familiar**).
- **PAPPS**: programa de la **semFYC**; **no es una ley**, sino un documento de consenso que fija cribados y consejos por edades. Ejemplos: preguntar por el **tabaco** al menos **cada 2 años** (no en todas las consultas), y **no hace falta**

volver a preguntar a mayores de 25 años que consta que nunca han fumado; **consejo de alimentación** al menos **cada 2 años**. **Aislamiento social en mayores**: factores de riesgo (≥ 75 años, sin hijos, jubilación), escalas **Gijón** y **OARS** de recursos sociales; las intervenciones más eficaces son **grupales con actividad social o apoyo** (no charlas de aprendizaje conductista). Las **alertas o fichas preventivas** en la historia electrónica aumentan los cribados (Brotons, 1996).

3. Detección precoz (cribado)

- Pruebas sistemáticas en personas **asintomáticas**: siempre **prevención secundaria**. Su resultado es **de presunción** (hay que confirmarlo); se hace en enfermedades frecuentes y graves y en los grupos de más riesgo; su rendimiento **no es el mismo** en sintomáticos que en asintomáticos.
- **Criterios de Wilson y Jungner (OMS)**: enfermedad importante con **fase latente reconocible**; el tratamiento precoz debe ser **más eficaz** que el tardío; prueba válida, fiable, segura, **aceptable** y coste-efectiva; recursos para confirmar y tratar los positivos; programa **continuo**.
- **Sensibilidad**: detecta a los **enfermos** (evita falsos negativos; la deseable en un cribado). **Especificidad**: identifica a los **sanos** (evita falsos positivos).
- **Cribado oportunista**: aprovechar cualquier contacto (TA, glucemia, IMC, escalas).

TRAMPAS DE EXAMEN

! "Detección precoz de la diabetes" = secundaria; "detección precoz del **pie diabético** en un diabético" = **terciaria** (se busca la complicación).

Necesidad	Escalas
Riesgo de **UPP**	**Norton**, **Braden** (incluye **fricción y cizallamiento**)
Riesgo de **caídas**	**Downton** (caídas previas, **medicamentos**, **déficits sensoriales**, estado mental y **deambulación**; **no valora el entorno**), **Morse**; **Tinetti** (equilibrio y marcha: **> 24 normal**, **19-24 riesgo**, **< 19 alto riesgo**); **"levántate y anda" cronometrado**: **≥ 20 segundos = alto riesgo**
Fragilidad	**SPPB** (equilibrio + **velocidad de la marcha** + **levantarse de la silla**; la prueba **preferente en la consulta**; **< 10** = fragilidad, riesgo de discapacidad y de caídas, no de deterioro cognitivo); **velocidad de la marcha en 4 m < 0,8 m/s**
Cognitivo	**MEC de Lobo** (adaptación española del Mini-Mental; 35 puntos frente a 30), **Pfeiffer**, test del reloj; el **test de las fotos** sirve **sea cual sea el nivel cultural**
Pronóstico del pluripatológico	**Índice PROFUND**: riesgo de **morir en los 12 meses** siguientes
Función familiar	**Apgar familiar** ("¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema?")
Depresión	**Yesavage** (anciano), Goldberg (ansiedad y depresión)
Alcohol	**AUDIT** (AUDIT-C, versión corta)
Nutrición del anciano	**MNA** (patrón oro)
Sobrecarga del cuidador	**Zarit**
Infancia	Percentiles, test de **Denver** (psicomotor), **M-CHAT** (autismo)

- **Diagnósticos de riesgo NANDA-I**: "Riesgo de… r/c factores de riesgo"; **nunca llevan "m/p"** (no hay signos porque el problema aún no existe). Ej.: Norton con alto riesgo → **Riesgo de deterioro de la integridad cutánea**; **Riesgo de caídas** (NOC: conducta de prevención de caídas; NIC: prevención de caídas). **NIC** = acciones de la enfermera; **NOC** = resultados del paciente.

4. Infancia

- **Obesidad infantil**: dieta, sedentarismo y **pantallas**, **déficit de sueño** (factor de riesgo, no protector), bajo nivel educativo materno y bajos ingresos. **Factor protector principal: lactancia materna**.

- **Accidentes**: **primera causa de muerte a partir del primer año** en países desarrollados (tráfico, ahogamiento, caídas, intoxicaciones, quemaduras). Prevención: supervisión, **sistemas de retención infantil**, hogar seguro.
- **Sillas del coche (SRI) por peso**: grupo 0 (hasta 10 kg), 0+ (hasta 13 kg), **grupo 1 (9-18 kg: un niño de 14 kg)**, grupo 2 (15-25 kg) y grupo 3 (22-36 kg). Por ley, los niños de **hasta 1,35 m** viajan con SRI y en los asientos **traseros** (es falso que la norma diga 1,50 m; esa altura es solo la recomendación para seguir usando el SRI). Taxi en ciudad: SRI recomendable pero no obligatorio; autobús: carrito en la zona habilitada, **en sentido contrario a la marcha** y frenado; avión: menores de 2 años en el regazo con cinturón supletorio.
- Desarrollo psicomotor: prematuridad, bajo peso, hipoxia → derivación a **Atención Temprana**. Caries, infecciones (no vacunación, guardería).
- Cuidados (**Programa del Niño Sano**): percentiles, EpS familiar, NAOS; **coberturas vacunales > 95%**; **lactancia materna exclusiva 6 meses** y complementada hasta los 2 años o más; enfermera escolar.

5. Adolescencia

- **Alcohol** (sustancia más consumida; patrón ***binge drinking***, atracón tipo "botellón"), **cannabis** (droga **ilegal** más consumida), tabaco y vapeadores.
- **Salud mental**: ansiedad, depresión, **conducta suicida** (en aumento), **TCA** (pico de inicio, sobre todo en chicas). Conductas sexuales de riesgo (ITS, embarazo), **ciberacoso** (anonimato, difusión masiva, acceso 24 horas), sedentarismo y accidentes de tráfico.
- Cuidados: **confidencialidad**, enfoque no directivo, **entrevista motivacional** (de elección, p. ej., ante consumo de cannabis), **consejo breve** (3-5 minutos; lo más coste-efectivo en tabaco), **educadores de iguales**, programa **"Salud y Escuela"** (enfermera de referencia en los institutos), habilidades para la vida (asertividad), doble método, seguridad vial.
- A partir de los **16 años** (o menor maduro), las consultas son confidenciales salvo riesgo grave.

6. Edad adulta

- **Riesgo cardiovascular**: **HTA** (un tercio de los adultos, muchos sin diagnosticar), **obesidad** (> 50% con exceso de peso; el **perímetro abdominal** es el mejor predictor de riesgo, mejor que el IMC), **diabetes tipo 2** y **dislipemia**. Tabaco (20-25%), alcohol, sedentarismo, abandono de la dieta mediterránea, estrés y riesgos laborales.
- **Actividad física (OMS)**: **≥ 150 minutos semanales moderados o 75 minutos vigorosos**.
- Riesgo global: tabla **SCORE** (mortalidad cardiovascular a 10 años, Europa) y **REGICOR** (adaptación **española** de Framingham, Girona).
- Tabaco: **intervención breve de las 5 aes** (averiguar, aconsejar, acordar, ayudar, asegurar el seguimiento).
- EpS individual sobre actividad física: lo clave es **explorar las experiencias y vivencias** del paciente con el ejercicio.

Cribado poblacional (cartera común)	Población	Prueba
Mama	Mujeres de 50-69 años	Mamografía cada 2 años
Cérvix	25-34 años / 35-65 años	Citología cada 3 años / **test de VPH** cada 5 años
Colorrectal	50-69 años	**Sangre oculta en heces cada 2 años**
Próstata	—	**Sin cribado poblacional** (sobrediagnóstico y sobretratamiento)

- Las consultas de enfermería logran buena adherencia y control en crónicos; campañas fuera del centro para captar a adultos sanos.
- En la mujer, el cáncer más frecuente tras el de **mama** es el **colorrectal**.

7. Personas mayores

- Objetivo: **prevenir la dependencia** y mantener la funcionalidad; **envejecimiento activo** (OMS: optimizar salud, **participación** y seguridad).
- **Caídas**: **un tercio de los > 65 años y la mitad de los > 80** se caen al menos una vez al año; el **20-30 %** sufre una lesión que compromete su autonomía o aumenta la mortalidad. En el domicilio: **fijar las alfombras** con base

antideslizante, buena luz, objetos de uso diario a mano. Factores **intrínsecos** (sarcopenia, déficits sensoriales, deterioro cognitivo, marcha, **benzodiacepinas**) y **extrínsecos** (alfombras, iluminación, calzado). **Mejor predictor: caída previa**. Consecuencia limitante: **síndrome poscaída** (miedo a caer). Abordaje **multicomponente**: escalas, ejercicio, revisión de fármacos y visita domiciliaria.

- **Delirium**: inicio **agudo**, nivel de conciencia **fluctuante** (frente a la demencia, insidiosa). Desencadenantes: infección urinaria, deshidratación, dolor, sondas, anticolinérgicos. Prevención **no farmacológica**: orientación (reloj, calendario), **gafas y audífonos**, sueño, movilización precoz e hidratación; evitar sedantes y contenciones.
- **Polimedicación: ≥ 5 fármacos**; criterios **STOPP** (detectan medicamentos **inapropiados**: benzodiacepinas, anticolinérgicos, antiinflamatorios no esteroideos) y **START** (detectan **tratamientos necesarios omitidos**); tienen también implicaciones de **ahorro económico**. **Conciliación de la medicación** al alta.
- **Fármacos en el mayor**: hay **más grasa corporal** → los fármacos **liposolubles** se acumulan (somnolencia prolongada, caídas). **Deshidratación**: menos agua corporal, **menos sed** y alteraciones de la renina-angiotensina (la masa magra **disminuye**, no aumenta).
- **Sarcopenia**: **primaria** si se debe a la edad. **EWGSOP2**: cribado con el cuestionario **SARC-F** y la **fuerza de agarre**; se **confirma** con la **masa muscular** baja; es **grave** si además el rendimiento físico es bajo (marcha ≤ 0,8 m/s). Ej.: SARC-F positivo, agarre 20 kg, masa muscular apendicular 18 kg y marcha 0,9 m/s = **sarcopenia confirmada** (no grave). Calidad de vida: cuestionario **SarQoL**. Otras: herramienta **Ishii** (edad, fuerza de agarre y **perímetro de la pantorrilla**); la **GLIS (2024)** la define por déficit de **masa, fuerza y fuerza específica** muscular; **obesidad sarcopénica** (ESPEN y EASO): 2 estadios según tenga complicaciones; las células senescentes empeoran la sarcopenia con factores **inflamatorios** (SASP).
- **Edadismo**: estereotipos y prejuicios por la edad; empeora la salud (estrés cardiovascular, menor esperanza de vida) y **retrasa** las medidas que la protegerían. Se combate reconociendo la **diversidad** de la vejez. El **enfoque basado en derechos** en los cuidados busca analizar desigualdades y **eliminar prácticas discriminatorias**.
- Malnutrición (**MNA**), deterioro cognitivo (MEC, Pfeiffer), depresión infradiagnosticada (Yesavage), soledad. Atención al **cuidador** (Zarit, respiro).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Un diagnóstico de riesgo con "manifestado por" es **falso**.

! **Primera causa de muerte en niños mayores de 1 año: accidentes.**

! Anciano hospitalizado que se agita de noche: primero medidas **ambientales y de orientación**, no sedantes ni contención.

! El PAPPS es de la **semFYC**, no una norma legal.